



Mapeo de ocupaciones de salud

Una metodología para su aplicación
en la Región de las Américas

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD EN LAS AMÉRICAS

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

Región de las Américas

Mapeo de ocupaciones de salud

Una metodología para su aplicación
en la Región de las Américas

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD EN LAS AMÉRICAS

Washington, D.C., 2025

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

Región de las Américas

Mapeo de ocupaciones de salud: Una metodología para su aplicación en la Región de las Américas
(Fortalecimiento de los sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas)

OPS/HSS/HR/25-0007

© Organización Panamericana de la Salud, 2025

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia de Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Organizaciones intergubernamentales (CC BY-NC-SA 3.0 IGO).

Con arreglo a las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra con fines no comerciales, siempre que se utilice la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons y se cite correctamente. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) respalda una organización, producto o servicio específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la OPS.

La OPS ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación. No obstante, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la OPS podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

Ilustración de portada: © GAMBOCORP MR DESIGN

Diseño: © Emilia Palomeque

Índice

Agradecimientos	iv
Abreviaciones.....	v
Presentación	vi
Introducción	1
¿A quién está dirigido el conjunto de metodologías y herramientas?	1
Cómo utilizar el conjunto de metodologías y herramientas.....	2
Antecedentes	3
Metodología	6
Búsqueda de las páginas web.....	7
Obtención de los documentos	8
Importación y procesamiento de los datos	8
Exportación a la hoja de cálculo de consolidación.....	9
Aplicación de la herramienta: profundizar el mapeo de ocupaciones en cada país	10
Perspectivas	12
Referencias.....	13
Anexos	14
Anexo 1. Equivalencia de ocupaciones en las cuentas nacionales del personal de salud y la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones	14
Anexo 2. Lista de palabras para la búsqueda de ocupaciones.....	26
Anexo 3. Herramienta de mapeo de ocupaciones, información recopilada	28
Figuras	
1. Términos y conceptos	5
2. Diagrama de flujo del desarrollo de la metodología	7
3. Número de sitios web por ministerios o gobiernos.....	7

Agradecimientos

Esta publicación fue elaborada por la Unidad de Recursos Humanos para la Salud (HR) del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud (HSS) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington, D.C., bajo la dirección de Benjamín Puertas. La coordinación de este proyecto estuvo a cargo de Ana Paula Cavalcante de Oliveira, especialista en desarrollo de recursos humanos para la salud, con el apoyo de las consultoras internacionales Isabel Duré y Mariana Lopes Galante. Este documento toma como base los aportes técnicos de Mario Dal Poz, Dercio Santiago da Silva Júnior y Fernando Santoro del Instituto de Medicina Social de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Se agradece especialmente a Gisele Almeida, asesora de evidencia e información de recursos humanos para la salud de HSS/HR de la OPS, por el liderazgo ejercido para llevar adelante este trabajo.

Abreviaciones

CINE	Clasificación Internacional Normalizada de la Educación
CIUO	Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
CNPS	Cuentas nacionales del personal de salud
COVID-19	Enfermedad por coronavirus 2019
OPS	Organización Panamericana de la Salud
RHS	Recursos humanos para la salud
SIRHS	Sistemas de información de recursos humanos para la salud
SIS	Sistemas de información para la salud

Presentación

Este documento describe la metodología propuesta para el mapeo de ocupaciones desarrollado por la Unidad de Recursos Humanos para la Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que ha sido validada por los países de la Región de las Américas.

Con base en un análisis exhaustivo de las clasificaciones ocupacionales nacionales, se desarrolló una metodología específica para identificar las ocupaciones en salud y compararlas con las propuestas en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). Esta metodología permite una armonización precisa entre las diferentes clasificaciones, facilitando la integración de los datos nacionales en un marco internacional estandarizado. Para desarrollar la mencionada metodología, también se empleó la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que permite asociar la categoría ocupacional con el o los niveles de calificación educativa requeridos para dicha ocupación en cada país.

La aplicación del Mapeo de Ocupaciones permitirá contar con una nomenclatura estandarizada a nivel nacional e internacional, con criterios claros para la recolección de datos y para la identificación de brechas y solapamientos entre categorías profesionales, facilitando procesos más consistentes de análisis y planificación de la fuerza de trabajo en salud. Invitamos a los países y a las instituciones del sector a utilizar esta metodología y avanzar en la consolidación de clasificaciones ocupacionales actualizadas y comparables en toda la Región.

Esperamos que esta herramienta resulte de gran utilidad para fortalecer la estructuración y estandarización de los datos sobre la fuerza de trabajo en salud, alineando las clasificaciones ocupacionales nacionales con marcos internacionales y mejorando así la precisión, confiabilidad y comparabilidad de la información empleada en la planificación y la toma de decisiones.

E. Benjamín Puertas,

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud

Introducción

Los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) son un tipo de sistemas de información para la salud (SIS) que involucran procesos estandarizados para recopilar, almacenar, administrar, analizar, usar y diseminar datos que produzcan información adecuada, oportuna y de calidad sobre el tamaño, la composición y la ubicación de los recursos humanos para la salud (RHS) a nivel nacional. Entre otros, incluyen datos demográficos, de capacitación y de patrones de migración.

Según la *Guía conceptual para el desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS)*, desarrollada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estos sistemas están conformados por normas, personas e instituciones que interactúan bajo la conducción y gobernanza de la autoridad nacional de salud. En ellos intervienen diversos actores, no solo del ámbito de la salud, sino también de la educación, el trabajo, las finanzas y otros ámbitos relacionados con la migración de profesionales de la salud.

Los SIRHS son un conjunto de herramientas de apoyo a la gestión de los RHS, capaces de optimizar las comunicaciones en este ámbito y ayudar en la toma de decisiones a mediano y largo plazo. Su construcción involucra una serie de decisiones y acciones a niveles estratégicos y operativos, que cada país orienta y organiza a partir de sus estructuras previas y capacidades actuales. No existe una receta única, por lo que cada país debe desarrollar su propia hoja de ruta.

No obstante, para facilitar a los países la identificación de su línea de base respecto de los SIRHS, así como la construcción de un itinerario hacia un SIRHS robusto, existe una serie de recomendaciones y posibles pasos que dar. La iniciativa de fortalecimiento de los SIRHS, de la que forma parte esta metodología, busca apoyar a los países en el desarrollo de sistemas sostenibles e interoperables que generen evidencia para la toma de decisiones y el diseño y la implementación de las políticas de salud. Esta iniciativa se estructura en torno a tres ejes: gobernanza y cooperación regional; marco conceptual y técnico con metodologías y herramientas clave, y producción y uso estratégico de evidencia sobre la fuerza de trabajo en salud (FTS).

¿A quién está dirigido el conjunto de metodologías y herramientas?

El conjunto de metodologías y herramientas fue creado para acompañar a las personas responsables de los trabajadores de salud de un país, que están en condiciones de influir en el desarrollo de políticas de RHS y en la asignación de recursos para el diseño y la implementación de SIRHS. Se trata, en suma, de un instrumento muy útil para los encargados de la toma de decisiones que buscan implementar un SIRHS con base en sus políticas de salud y buenas prácticas.

Este conjunto de metodologías y herramientas también será de utilidad para los planificadores, administradores y profesionales de la salud de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que trabajen con la FTS de su país y necesiten conocer la situación actual, los escenarios alternativos y las necesidades de desarrollo para lograr sistemas de salud resilientes.

Cómo utilizar el conjunto de metodologías y herramientas

El conjunto de metodologías y herramientas contiene una selección de guías, documentos, instrumentos y manuales prácticos desarrollados con base en la evidencia y la participación de los países de la Región de las Américas. Este conjunto está compuesto por el mapeo de actores, el mapeo de ocupaciones y la evaluación de madurez de los SIRHS. Tales materiales están alineados con las cuentas nacionales del personal de salud y orientados a apoyar la formulación de políticas informadas por evidencias dirigidas a respaldar un sistema de salud de calidad.

Si bien los recursos de este conjunto de metodologías y herramientas se centran en apoyar la cooperación técnica para que los países de las Américas puedan desarrollar sus SIRHS, resulta importante destacar que se trata de un cuerpo flexible, que se ajusta a las necesidades de los sistemas de salud de la Región a través de los aportes de una amplia gama de profesionales que trabajan en temas relacionados con la gestión y la planificación de la FTS.

Para facilitar el acceso y uso de estos recursos, el presente conjunto se ha estructurado en categorías a las que puede accederse a través del sitio web de la OPS (<https://www.paho.org/es/temas/evidencia-e-informacion-recursos-humanos-para-salud>) o mediante el código QR que aquí se presenta. En dicho sitio, el lector encontrará una lista de los títulos de cada documento, con un breve resumen de su contenido y una sección que describe a quién está dirigido cada uno. Los materiales incluyen orientación sobre la evaluación de la madurez de los SIRHS, el mapeo de los actores para la gobernanza de los datos de los RHS, las ocupaciones de los trabajadores de salud, y las cuentas nacionales del personal de salud, entre otros temas.



Antecedentes

El impacto de la pandemia de COVID-19 ha resaltado nuevamente la importancia de la colaboración internacional en el sector de la salud y ha puesto de relieve cómo las limitaciones en el intercambio de conocimientos y recursos contribuyen a aumentar la desigualdad, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos.

El personal de salud es el pilar de los sistemas de salud a nivel mundial. Sin embargo, las evaluaciones internacionales de los trabajadores de salud y de los insumos no monetarios de los sistemas de salud siguen siendo menos comunes que las comparaciones de los gastos sanitarios. Esto obedece, en parte, a la falta de un marco común y de datos adecuados para su análisis.

En efecto, uno de los factores que limita el análisis es la falta de estandarización de las clasificaciones ocupacionales, lo que afecta la capacidad de los países para intercambiar información crítica, asignar recursos de manera adecuada y ofrecer una respuesta coordinada a las crisis globales en materia de salud (1).

Para poder comparar la situación del personal de salud de los distintos países o propiciar el intercambio de mejores prácticas entre ellos, es necesario entender la manera en que cada país define y clasifica a su personal de salud. La planificación del personal de salud se sustenta en la disponibilidad de información lo más exhaustiva posible sobre los distintos grupos ocupacionales. Los enfoques existentes suelen centrarse sobre todo en los profesionales altamente calificados, como los profesionales de medicina y de enfermería, y no prestan suficiente atención a otras profesiones u ocupaciones importantes del sector de la salud (2).

Un sistema de clasificación estandarizado facilita a los países la compilación y el análisis de datos sobre todos los grupos ocupacionales del sector de la salud de forma congruente. Esto permite abordar la planificación del personal de salud con un enfoque más holístico, que tenga en cuenta las diversas funciones y responsabilidades de los distintos profesionales. A su vez, los países podrán asegurarse de que sus datos sobre el personal de salud están en consonancia con las clasificaciones internacionales, lo que facilita la realización de comparaciones y el intercambio de información.

La armonización de las normas y regulaciones sobre bases metodológicas comunes es fundamental para que los diversos sectores desarrollen su actividad con eficacia. La estandarización no solo facilita la interoperabilidad de los sistemas, sino que, además, aumenta la calidad de los servicios, fortaleciendo los sistemas de salud de los países y mejorando el bienestar y la calidad de vida de su población.

Por otra parte, las cuentas nacionales del personal de salud (CNPS) (3) aportan un marco propicio para la comparabilidad de la información del personal de salud a nivel global. Comparar las ocupaciones del sector salud bajo el marco de las CNPS permitirá realizar un análisis más amplio y preciso de la situación de los países de la Región de las Américas.

El mapeo de ocupaciones en salud es un proceso necesario para armonizar las clasificaciones ocupacionales nacionales con la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) (4), lo que facilita la correcta presentación de los datos en las CNPS. Este proceso implica la comparación y alineación de las diferentes categorías ocupacionales utilizadas en cada país con las establecidas por la CIUO, y permite una representación coherente y precisa de las ocupaciones del sector salud a nivel internacional.

La ejecución del mapeo de ocupaciones requiere una estrecha colaboración entre los diversos actores, así como un profundo conocimiento de las estructuras ocupacionales existentes en cada país. Aunque cada Estado puede tener su propia metodología de clasificación, la adopción de estándares internacionales como la CIUO es vital para garantizar la coherencia en la presentación de los datos. Este enfoque permite que los países informen de manera adecuada y precisa sobre su personal de salud, apoyando tanto la toma de decisiones nacionales como la cooperación internacional en materia de salud.

Para desarrollar esta metodología de mapeo de ocupaciones, se realizó una búsqueda a fin de recopilar las clasificaciones de ocupaciones del sector de la salud que se encontraban disponibles en Internet. Dicha búsqueda y el posterior análisis revelaron un desafío común entre los 41 países y territorios analizados en las Américas: la necesidad de armonizar sus clasificaciones con la CIUO (4) y las CNPS (3). La falta de congruencia entre las categorías empleadas se evidenció como una cuestión crítica que se debe abordar rápidamente.

Una ocupación se define como un conjunto de trabajos con tareas y funciones similares, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la CIUO. Este concepto permite que una persona esté vinculada a una ocupación mediante su empleo actual, un segundo trabajo, un futuro empleo o uno previo. Por otro lado, una profesión implica especialización y formación académica formal, complementada con entrenamiento específico y, en muchos casos, certificaciones o licencias que cumplen con normativas y estándares establecidos, además de adherirse a un código ético. La figura 1 resalta cómo el ámbito laboral y el de la formación interactúan para definir el desempeño profesional. Elementos clave como el puesto de trabajo —que detalla las tareas asignadas en una organización—, la habilitación —que certifica la capacidad legal para ejercer funciones en el caso de profesiones reguladas— y el título académico o formación en servicio —que desarrolla competencias a través de procesos educativos, por las que se puede acceder a una certificación—, se interconectan para integrar competencias, normativas y desarrollo profesional continuo, asegurando la calidad laboral y formativa.

En la primera revisión de los documentos para la elaboración de esta metodología, se hizo evidente la complejidad del abordaje de las ocupaciones, al analizar el modo en que los distintos países decidieron realizar la categorización de las profesiones en el sector de la salud. Algunos países optaron por adoptar las listas de las CNPS o la CIUO en su totalidad, mientras que otros decidieron elaborar sus propias clasificaciones, sin correspondencia con las normas internacionales. Un tercer grupo se inclinó por un enfoque híbrido, en el que dichas listas fueron adoptadas de forma parcial, lo que dio lugar a una categorización mixta de las ocupaciones.

FIGURA 1 Términos y conceptos



Fuente: elaboración propia, con base en Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Instituto de Estadísticas. Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE 2011. Montreal: UIS; 2013. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220782>; Organización Internacional del Trabajo. Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08) [Internet]. Ginebra: OIT; 2012. Disponible en: <https://webapps.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/index.htm>; UNESCO. Tesoro de la UNESCO [Internet]. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 1977. Disponible en: <https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/index>; Gammarano R. Trabajo y la ocupación no son sinónimos. Ginebra: OIT; 2019. Disponible en: <https://ilostat.ilo.org/es/blog/work-and-employment-are-not-synonyms/>; Organización Internacional del Trabajo. ILO Thesaurus: 13 Trabajo y empleo. Ginebra: OIT; s.f. Disponible en: <https://metadata.ilo.org/thesaurus/702059032.html>.

Además de la falta de estandarización, también surgieron grandes dificultades para encontrar y acceder a los documentos en Internet. La limitada accesibilidad de los registros oficiales en las áreas de estadística agregó una capa extra de complejidad a la obtención y verificación de las clasificaciones ocupacionales de los países de la Región.

A continuación, se detalla la metodología utilizada para la construcción de la herramienta y el procedimiento propuesto para el mapeo de ocupaciones.

Metodología

La metodología incluyó una serie de etapas que se planificaron y ejecutaron cuidadosamente con el propósito de obtener, organizar y procesar datos de las clasificaciones de ocupaciones nacionales de los 41 países y territorios de las Américas.¹ El objetivo principal fue establecer un método eficaz que permitiera extraer, procesar y consolidar los datos de interés que posteriormente pudieran ser comparables a nivel regional. A continuación, se describe brevemente cada etapa del proceso.

Etapas 1. Búsqueda de las páginas web: la primera etapa consistió en encontrar y registrar las páginas web pertinentes de los 41 países y territorios analizados.

Etapas 2. Obtención de los documentos: después de organizar debidamente la lista de las páginas web, se procedió a obtener los documentos de la clasificación nacional de ocupaciones de cada país.

Etapas 3. Procesamiento de los datos: se importaron los datos de las páginas web a una hoja de cálculo (<https://www.paho.org/es/documentos/ocupaciones-por-pais>) y se seleccionaron las ocupaciones del sector de la salud. Se procesaron y exportaron los datos consolidados a un nuevo documento.

Etapas 4. Traspaso de los datos: se reunió la información de todos los países analizados en una hoja de cálculo común de forma organizada para facilitar la interpretación de los datos y comparar las denominaciones de cada país con las CNPS y la CIUO.

La metodología se planificó y se puso en práctica con sumo cuidado para garantizar la exactitud y la congruencia de los datos recopilados (figura 2). También pueden consultarse en la misma hoja de cálculo todos los documentos que se encontraron en Internet en los que figuran las listas de ocupaciones oficiales de los países, así como las listas de la CIUO y las CNPS.

¹ Se analizan los 41 países y territorios siguientes: Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

FIGURA 2 Diagrama de flujo del desarrollo de la metodología



CIUO: Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones; CNPS: cuentas nacionales del personal de salud.

A continuación, se describe cada una de estas cuatro etapas.

Búsqueda de las páginas web

Se examinaron los sitios web oficiales de los gobiernos, los ministerios de Trabajo, Salud y Educación, los institutos de estadística y los enlaces disponibles a las clasificaciones nacionales de ocupaciones.

En primer lugar, se realizó una encuesta para identificar cuáles páginas web representaban a cada país, con el fin de identificar sus sitios oficiales. A continuación, se efectuaron búsquedas en los idiomas oficiales de los países de la Región (portugués, español, francés, holandés e inglés).

La metodología para encontrar las páginas web consistió en emplear la fórmula “términos de búsqueda + nombre del país” en los motores de búsqueda para encontrar los sitios oficiales (figura 3).

FIGURA 3 Número de sitios web por ministerios o gobiernos

Gobierno central	40 países y territorios
Ministerios de Trabajo	39 países y territorios
Ministerios de Salud	40 países y territorios
Ministerios de Educación	40 países y territorios
Institutos de estadística	41 países y territorios
Clasificación nacional de ocupaciones	30 países y territorios No se pudieron encontrar las clasificaciones nacionales de ocupaciones de los siguientes países y territorios: Bahamas, Belice, Granada, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Suriname y Venezuela (República Bolivariana de).

Obtención de los documentos

Los documentos de la clasificación nacional de ocupaciones de cada país se obtuvieron a través de las páginas web identificadas. Se descargaron documentos de 29 países; el único enlace que presentó problemas fue el correspondiente al documento de Jamaica, que no pudo descargarse correctamente. Una vez que se identificó —en dichos documentos— la información relativa a las clasificaciones de las ocupaciones, se copió y pegó en una hoja de cálculo.

Importación y procesamiento de los datos

El proceso se llevó a cabo con todos los archivos encontrados en Internet y se creó un archivo para cada país.

La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) (4) se estructura en cuatro niveles jerárquicos: el primero comprende grandes grupos, y es el que constituye las categorías más amplias; el segundo incluye los subgrupos principales; el tercero abarca los subgrupos menores, y el cuarto nivel se refiere a las ocupaciones específicas. Cada nivel se organiza de forma que las ocupaciones más similares en términos de habilidades y funciones se agrupan juntas, lo que permite un análisis más detallado de las dinámicas laborales y las necesidades del mercado de trabajo.

Primero se buscaron las ocupaciones usadas en las cuentas nacionales del personal de salud (CNPS), para lo cual se extrajeron los archivos de los manuales disponibles en tres idiomas (español, inglés y portugués). Una vez obtenidos los documentos, se copiaron y estandarizaron los datos de la lista con las clasificaciones y sus respectivas ocupaciones.

Los códigos utilizados para las ocupaciones en las CNPS y la CIUO son diferentes entre sí. Sin embargo, se ha realizado una equivalencia de estas ocupaciones para garantizar la compatibilidad y coherencia de los datos informados (véase el anexo 1). Para facilitar esta armonización, se definieron 41 ocupaciones en las CNPS, lo que permite a los países reportar datos de manera estandarizada y comparable a nivel internacional.

Luego, se trasladaron las listas de ocupaciones a una hoja de cálculo y se distribuyeron por niveles, del 1 al 4, donde el nivel 1 es el más amplio y el 4 el más detallado. Este proceso se realizó en los tres idiomas disponibles y se repitió con el documento de la CIUO en inglés, estandarizando los datos en un cuadro con todas las ocupaciones.

A continuación, se presentan los detalles de la hoja de cálculo llamada “CNPS x CIUO08” dentro del archivo consolidado, que muestra las equivalencias entre las ocupaciones de la CIUO y las CNPS G (<https://www.paho.org/es/documentos/ocupaciones-por-pais>). Se incluyeron columnas para las categorías “Definición”, “Ejemplos de ocupaciones aquí clasificadas” y “Notas”, disponible en los tres idiomas.

Se incluye otra hoja de cálculo titulada “Definiciones de ocupaciones”, basada en los documentos de las CNPS y la CIUO, donde se detallan las definiciones de los grupos, los subgrupos y las ocupaciones en los tres idiomas mencionados. Finalmente, se copiaron, pegaron y procesaron las clasificaciones ocupacionales de cada país en su respectivo archivo; para procesar los datos se utilizaron fórmulas específicas del programa Microsoft Excel.

Posteriormente, se identificaron las ocupaciones estandarizadas del sector de la salud. Para ello, se creó una fórmula que permitía identificar aquellas ocupaciones que contenían al menos una de las palabras de una lista determinada, teniendo en cuenta el idioma del documento. Se elaboraron listas estandarizadas en los tres idiomas señalados (véase el anexo 2). En el caso de los países con otros idiomas, los términos se tradujeron al inglés para comparar los datos. También se utilizaron palabras clave con caracteres comodín. Por último, se creó una hoja de

cálculo titulada “Exportación”, que contenía las ocupaciones filtradas en la etapa de procesamiento. En este punto, las ocupaciones se estandarizaron de conformidad con la distribución de los cinco niveles siguientes, a saber: mayor, submayor, menor, unidad y unidad detallada. Este último nivel se utiliza únicamente en la documentación basada en cinco niveles de la CIUO, y no todos los países cuentan con clasificaciones nacionales que sigan esta estructura completa.

Exportación a la hoja de cálculo de consolidación

Una vez que se armonizaron los datos procesados del documento de cada país con las listas de ocupaciones del sector de la salud, se procedió a incluirlos en el “archivo maestro” (u hoja de cálculo maestra), que contiene la información de todos los países (véase el anexo 3).

Asimismo, luego de consignar las denominaciones de las clasificaciones nacionales en la hoja de cálculo maestra, se compararon las ocupaciones de cada país con las de la CIUO para reflejar el grado de estandarización de las cuentas del personal de salud de cada país.

Se elaboró una pestaña para cada país, en la cual se presenta la CIUO. Al desplazar la hoja de cálculo hacia la derecha, se pueden ver las clasificaciones distribuidas por niveles, así como las columnas para el llenado de la definición, los ejemplos y las notas.

Las columnas referentes a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) del 2011 (5) contienen un menú desplegable con las siguientes clasificaciones:

- Nivel CINE 0 – Educación de la primera infancia
- Nivel CINE 1 – Educación primaria
- Nivel CINE 2 – Educación secundaria baja
- Nivel CINE 3 – Educación secundaria alta
- Nivel CINE 4 – Educación postsecundaria no terciaria
- Nivel CINE 5 – Educación terciaria de ciclo corto
- Nivel CINE 6 – Educación terciaria o nivel equivalente
- Nivel CINE 7 – Maestría, especialización o equivalente
- Nivel CINE 8 – Doctorado o equivalente

Se comprobó que la mayoría de los países se ajustan al modelo de la CIUO, con pocas modificaciones o, en algunos casos, con solamente algún detalle diferente. Sin embargo, deben realizarse estudios adicionales para entender las diferencias específicas entre las clasificaciones de los países de la Región.

Aplicación de la herramienta: profundizar el mapeo de ocupaciones en cada país

La elaboración de una metodología para comparar las clasificaciones ocupacionales de los distintos países con la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones y las cuentas nacionales del personal de salud representa un importante avance hacia la estandarización y la comprensión de las estructuras ocupacionales de las Américas. Esta metodología aporta un enfoque sistemático para armonizar las clasificaciones nacionales de ocupaciones, lo que, a su vez, permitirá promover resultados más comparables en materia de investigaciones sobre el mercado de trabajo en el sector de la salud.

El uso de esta herramienta, diseñada en el marco de la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud, permitirá aumentar la precisión de las estadísticas nacionales, así como mejorar la planificación del personal de salud y la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios de los países.

El archivo de Excel proporcionado no solo es editable, sino que también está diseñado para ser construido y adaptado por cada país, con base en un enfoque colectivo e intersectorial. Dicho enfoque colaborativo permitirá que cada país personalice su catálogo ocupacional de acuerdo con sus necesidades y contextos específicos.

De esta manera, los países pueden verificar las ocupaciones identificadas a través de la metodología desarrollada y añadir información sobre las ocupaciones que no estén presentes en el archivo.

Al desplazar la pestaña de su país hacia la derecha, se encontrarán columnas destinadas al llenado de la “definición” y ejemplos de ocupaciones que pueden ser completados directamente en el archivo proporcionado. También hay columnas para identificar el nivel CINE correspondiente a cada ocupación de su país; si es necesario agregar otro nivel, puede hacerse en la columna adyacente. Además, existe la opción de incluir información para determinar si la ocupación está regulada² (o no) en el país. Todas estas informaciones pueden ser completadas de manera rápida y sencilla mediante el menú desplegable disponible en el archivo.

Se recomienda que los países inicien este proceso haciendo hincapié en las ocupaciones identificadas como prioritarias porque tienen un mayor interés nacional para los países de la Región. Tales ocupaciones son: medicina, enfermería, partería, odontología, farmacia, fisioterapia, psicología y trabajo comunitario de salud.

² Una profesión regulada es aquella para la cual existen estándares y requisitos legales o normativos específicos para su ejercicio, como títulos habilitantes, certificaciones o registros profesionales.

Por otro lado, una carrera regulada implica que existen estándares y criterios formales que aseguran que los contenidos curriculares de esa carrera sean equivalentes en todas las instituciones que la imparten en el país. Esto normalmente busca garantizar la formación homogénea de los graduados. La acreditación se relaciona con la verificación de la calidad de los programas educativos ofrecidos por las instituciones.

Al comenzar con estas áreas críticas, será posible construir una base sólida que luego podrá expandirse progresivamente hasta incluir todas las ocupaciones relevantes. Este método escalonado asegura que, a pesar de los desafíos de tiempo y recursos, el avance sea constante y significativo.

Para optimizar su aplicación, se recomienda conformar una mesa de trabajo intersectorial en cada país entre las áreas de salud, estadísticas, trabajo y educación para alcanzar una interpretación más profunda de los términos oficiales. Esto permitirá aumentar progresivamente la calidad de la información que se facilita en las CNPS.

Perspectivas

La metodología propuesta ofrece un punto de partida sólido para que los países avancen en el mapeo de sus ocupaciones, facilitando una comprensión más profunda de su fuerza laboral.

La armonización de las clasificaciones ocupacionales es un proceso dinámico, no estático, por lo que las iniciativas futuras deberán incluir la actualización periódica de las listas de ocupaciones, la incorporación de nuevas categorías ocupacionales y una mejora en la accesibilidad a los datos. Además, la colaboración continua con países y organizaciones regionales será esencial para mantener la relevancia y precisión de las clasificaciones.

Los resultados obtenidos no marcan el final del proceso, sino que ofrecen a los países la oportunidad de revisar y mejorar sus propias clasificaciones. Armonizar las categorías nacionales con las clasificaciones internacionales como la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones o las cuentas nacionales del personal de salud funciona como un incentivo para que cada país realice una revisión interna de sus estructuras ocupacionales con el objetivo de perfeccionar las definiciones y categorías existentes.

Los recursos de este conjunto de herramientas están diseñados para apoyar la cooperación técnica en el desarrollo de mapeos de ocupaciones en los países de la Región, pero se trata de un instrumento flexible, que se ajusta a las necesidades específicas de cada sistema de salud. El mapeo de ocupaciones facilita la creación de un catálogo con la comparación entre las clasificaciones nacionales e internacionales, y podrá ser utilizado como un insumo para el mejor reporte de datos.

Aunque el esfuerzo propuesto por el presente estudio requiere tiempo y dedicación, los beneficios a largo plazo son considerables. Al completar el proceso, cada país dispondrá de un catálogo exhaustivo de sus ocupaciones, con definiciones precisas que facilitarán la comparabilidad con los datos internacionales.

Referencias

1. Watts RD, Bowles DC, Ryan E, Fisher C, Li IW. No Two Workforces Are the Same: A Systematic Review of Enumerations and Definitions of Public Health Workforces. *Front Public Health*. 2020;8:588092. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33330331>.
2. Kuhlmann E, Batenburg R, Wismar M, Dussault G, Maier CB, Glinos IA, et al. A call for action to establish a research agenda for building a future health workforce in Europe. *Health Res Policy Syst*. 2018;16(1):52. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29925432>.
3. Organización Mundial de la Salud. Cuentas Nacionales del Personal de Salud: Un manual [National Health Workforce Accounts: A Handbook]. Ginebra: OMS; 2019. Disponible en: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/330361/9789243513119-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
4. Organización Internacional del Trabajo. CIUO - Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. 2017. Disponible en: <https://webapps.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/index.htm>.
5. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE). París: UNESCO; 2011.

Anexo 1. Equivalencia de ocupaciones en las cuentas nacionales del personal de salud y la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones

Código CNPS	Nombre	Código CIUO	Definición	Ejemplos de ocupaciones
1				
1.1	Médicos generalistas (incluidos médicos de familia)	2211	Los médicos generalistas (incluidos médicos de familia y de atención primaria) diagnostican, tratan y previenen enfermedades, afecciones, traumatismos y otras deficiencias físicas y mentales, y mantienen la salud general de las personas aplicando los principios y procedimientos de la medicina moderna. Planifican, supervisan y evalúan la ejecución de los planes de atención y tratamiento llevados a cabo por otros prestadores de servicios de salud. No limitan su ejercicio profesional a determinadas categorías de enfermedades o métodos de tratamiento, y pueden responsabilizarse de la prestación de atención médica continua e integral a personas, familias y comunidades.	Médico generalista, médico (general), funcionario médico (general), médico de cabecera, médico de familia, médico de atención primaria de salud, médico distrital, médico residente en formación en medicina general, funcionario médico municipal, especialista en medicina de familia y comunitaria, oficial médico
1.2	Médicos especialistas	2212	Los médicos especialistas diagnostican, tratan y previenen enfermedades, afecciones, traumatismos y otras deficiencias físicas y mentales mediante técnicas especializadas analíticas, diagnósticas, médicas, quirúrgicas, físicas y psiquiátricas, aplicando los principios y procedimientos de la medicina moderna. Planifican, supervisan y evalúan la ejecución de los planes de atención y tratamiento llevados a cabo por otros prestadores de servicios de salud. Se especializan en determinadas categorías de enfermedades, tipos de paciente o métodos de tratamiento, y pueden desempeñar actividades docentes y de investigación en sus respectivas áreas de especialización.	Médico especialista en medicina interna, cirujano, anestesiólogo, cardiólogo, intensivista, emergentólogo, oftalmólogo, ginecólogo, obstetra, pediatra, anatomopatólogo, especialista en medicina preventiva, psiquiatra, médico radiólogo o especialista en imágenes, médico especialista en formación

Código CNPS	Nombre	Código CIUO	Definición	Ejemplos de ocupaciones
1.2.1	Pediatras generales	2212	Médicos con formación en especialidades pediátricas y otras disciplinas afines que se centran en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de salud de los lactantes, los niños y los adolescentes.	Pediatra, neonatólogo
1.2.2	Obstetras y ginecólogos	2212	Médicos con formación en especialidades ginecobstétricas y otras disciplinas afines que se centran en el aparato reproductor femenino incluso antes, durante y después del embarazo y el parto.	Ginecólogo, obstetra, tocoginecólogo
1.2.3	Psiquiatras	2212	Médicos con formación en especialidades psiquiátricas y otras disciplinas afines que se centran en el estudio y el tratamiento de las enfermedades mentales y los trastornos del comportamiento.	Psiquiatra, psiquiatra infantil, gerontopsiquiatra, neuropsiquiatra
1.2.4	Grupo de médicos con otras especialidades clínicas	2212	Médicos especialistas con formación en especialidades médicas clínicas y disciplinas afines (no clasificadas en otra parte) que se centran en el diagnóstico, el manejo clínico y el tratamiento no quirúrgico de los problemas de salud.	Médico especialista en cardiología, dermatología, medicina legal y forense, gastroenterología, hematología, inmunología, enfermedades infecciosas, medicina interna, neurología, medicina ocupacional, oncología, radiología o diagnóstico por imágenes, medicina rehabilitadora, neumonología
1.2.5	Grupo de médicos con otras especialidades quirúrgicas	2212	Médicos especialistas con formación en especialidades quirúrgicas y disciplinas afines (no clasificadas en otra parte) que se centran en el tratamiento de los problemas de salud por medios quirúrgicos.	Médico especialista en cirugía general, medicina de emergencia y accidentes, anestesiología, cuidados intensivos, neurocirugía, oftalmología, ortopedia y/o traumatología, otorrinolaringología, cirugía plástica, cirugía torácica, cirugía cardiovascular
1.2.6	Otros médicos especialistas	2212	Este grupo abarca los médicos de especialidades no incluidas entre las especialidades ginecobstétricas, pediátricas, psiquiátricas, médicas clínicas, quirúrgicas o especialidades clasificadas en otra parte.	Dermatología, otorrinolaringología, traumatología / cirugía ortopédica, urología, gastroenterología, reumatología, nefrología, endocrinología, neurología, oftalmología, anestesiología, medicina legal / forense, geriatría, medicina del deporte, infectología, alergología, cardiología, medicina nuclear, cirugía, y otras especialidades médicas
1.3	Médicos sin especificación	221	Médicos que estudian, diagnostican, tratan y previenen enfermedades, afecciones, traumatismos y otras deficiencias físicas y mentales humanas aplicando los principios y procedimientos de la medicina moderna. Planifican, supervisan y evalúan la ejecución de los planes de atención y tratamiento llevados a cabo por otros prestadores de servicios de salud, y desempeñan actividades docentes y de investigación en el ámbito médico.	Incluye médico generalista y médico especialista

Código CNPS	Nombre	Código CIUO	Definición	Ejemplos de ocupaciones
2				
2.1	Enfermeras profesionales	2221	Las enfermeras profesionales (tituladas) prestan servicios de tratamiento, apoyo y atención a las personas que precisan cuidados de enfermería por envejecimiento, enfermedades, traumatismos u otras deficiencias físicas o mentales, así como posibles riesgos para la salud, de conformidad con las prácticas y normas de la enfermería moderna. Se responsabilizan de la planificación y el manejo del cuidado de los pacientes, incluida la supervisión de otros trabajadores de la salud, y trabajan de manera autónoma o formando equipo con médicos y otros integrantes en la aplicación práctica de las medidas preventivas y curativas tanto en el entorno hospitalario como en la comunidad.	Enfermera profesional, enfermera especialista, licenciada en enfermería, enfermera clínica, enfermera de práctica avanzada, enfermera distrital, enfermera instrumentista (o instrumentadora), enfermera de atención primaria, enfermera de centro quirúrgico, enfermera de salud pública, enfermera de anestesia, enfermera educadora, enfermera municipal
2.2	Enfermeras asociadas profesionales	3221	Las enfermeras asociadas profesionales (tituladas) prestan cuidados básicos de enfermería y cuidados personales a los pacientes que los precisan por envejecimiento, enfermedades, traumatismos u otras deficiencias físicas o mentales. Brindan consejos sobre salud a pacientes y familiares, vigilan el estado de los pacientes, y llevan a cabo los planes de cuidado, tratamiento y derivación generalmente establecidos por un médico, una enfermera titulada u otro profesional superior de la salud.	Enfermera asociada, enfermera auxiliar, enfermera asistente
2.3	Enfermeras sin especificación	NA		Enfermera
3				
3.1	Parteras profesionales	2222	Las parteras o matronas tituladas planifican, gestionan, prestan y evalúan los cuidados y servicios de partería antes, durante y después del embarazo y el parto. Proporcionan atención obstétrica para reducir los riesgos para la salud de la madre y el recién nacido de conformidad con las prácticas y normas de la partería moderna, y trabajan de manera autónoma o en equipo con otros prestadores de servicios de salud. Pueden desempeñar actividades docentes en el ámbito de la partería y actividades de investigación sobre las prácticas y procedimientos de partería, tanto en el entorno hospitalario como en la comunidad.	Partera profesional, licenciada/o en obstetricia, matrona profesional, partera de salud pública

Código CNPS	Nombre	Código CIUO	Definición	Ejemplos de ocupaciones
3.2	Parteras asociadas profesionales	3222	Las parteras o matronas asociadas prestan asesoramiento y cuidados básicos de salud antes, durante y después del embarazo y el parto. Brindan consejos a las mujeres, familias y comunidades sobre el parto fisiológico y los planes de preparación ante posibles urgencias obstétricas, lactancia materna, cuidados de puericultura, planificación familiar y otros temas afines; vigilan el estado de salud durante el embarazo y el parto; y llevan a cabo los planes de cuidado, tratamiento y derivación generalmente establecidos por un médico, una partera o matrona titulada, u otro profesional superior de la salud.	Partera asociada, partera auxiliar, matrona (o comadrona) auxiliar, partera asistente, matrona (o comadrona) asistente
3.3	Parteras sin especificación	NA		Parteras, comadronas, matronas
4	Dentistas	2261	Los dentistas y/u odontólogos y afines diagnostican, tratan y previenen las enfermedades, traumatismos y anomalías de los dientes, la boca, los maxilares y tejidos asociados aplicando los principios y procedimientos de la odontología moderna. Usan una amplia gama de técnicas especializadas (diagnósticas, quirúrgicas y de otro tipo) para promover y restaurar la salud bucodental.	Dentista, odontólogo, cirujano dental, endodoncista, cirujano maxilofacial, cirujano oral, periodoncista, ortodoncista, odontopediatra, protesista, estomatólogo
5	Asistentes y terapeutas dentales	3251	Los asistentes y terapeutas dentales prestan servicios básicos de cuidado dental para la prevención y el tratamiento de las enfermedades y anomalías de los dientes y la boca, de conformidad con los planes y procedimientos asistenciales establecidos por un dentista u otro profesional superior de la salud bucodental. Examinan la boca, los dientes y otras estructuras relacionadas para evaluar el estado de salud bucodental de los pacientes; brindan consejos sobre higiene bucodental; llevan a cabo procedimientos dentales básicos o rutinarios; y ayudan a los dentistas en los procedimientos dentales complejos.	Asistente dental, higienista dental, terapeuta dental
6	Técnicos en prótesis dentales	3214 (parte)	Los técnicos en prótesis dentales diseñan, ajustan, mantienen y reparan prótesis dentales y otros aparatos médicos y dentales siguiendo la prescripción o las instrucciones establecidas por un profesional superior de la salud. Pueden ocuparse del mantenimiento de una amplia gama de prótesis y dispositivos de apoyo para corregir problemas médicos y dentales de tipo físico, como collarines cervicales, férulas ortopédicas, miembros artificiales, audífonos, plantillas ortopédicas, dentaduras postizas, coronas dentales y pónicos.	Protésico dental, técnico en prótesis dentales

Código CNPS	Nombre	Código CIUO	Definición	Ejemplos de ocupaciones
7	Farmacéuticos	2262	Los farmacéuticos almacenan, conservan, preparan y dispensan medicamentos y otros productos médicos. Brindan consejos sobre el uso adecuado y los efectos adversos de los medicamentos en virtud de las recetas y las prescripciones emitidas por un médico u otro profesional de la salud. Colaboran asimismo en la investigación, el ensayo, la preparación, la prescripción y la vigilancia o seguimiento de los medicamentos y otros tratamientos médicos para optimizar la salud humana.	Farmacéutico, farmacéutico hospitalario (o de hospital), farmacéutico industrial, químico farmacéutico
8	Técnicos de farmacia	3213	Los técnicos y asistentes farmacéuticos desempeñan diversas tareas vinculadas a la dispensación de medicamentos y otros productos médicos bajo la orientación de un farmacéutico u otro profesional superior de la salud calificado. Llevan el inventario, preparan y almacenan los medicamentos y otros productos de farmacia y parafarmacia, y pueden dispensar los medicamentos a las personas y dar instrucciones sobre su uso en la forma prescrita por los profesionales superiores de la salud.	Técnico farmacéutico, asistente de farmacia
9	Personal paramédico	2240	El personal paramédico presta servicios médicos de asesoramiento, diagnóstico, tratamiento y prevención más restringidos en cuanto a alcance y complejidad que los que llevan a cabo los médicos. Trabajan de manera autónoma o bajo supervisión limitada por parte de un médico, y llevan a cabo procedimientos clínicos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento y la prevención de enfermedades, traumatismos y otras deficiencias físicas o mentales frecuentes en comunidades específicas.	Paramédico de primeros cuidados, paramédico de atención avanzada, asociado quirúrgico
10	Científicos de laboratorio clínico y de anatomía patológica	NA	Los científicos de laboratorio clínico y de anatomía patológica son profesionales que realizan análisis, investigaciones y diagnósticos de muestras biológicas humanas mediante técnicas avanzadas de laboratorio. Realizan análisis clínicos e interpretación de resultados, estudios microscópicos de tejidos y células para diagnóstico de enfermedades, identificación de microorganismos, análisis bioquímicos y garantía de calidad de resultados diagnósticos. Poseen conocimiento profundo de biología, química y patología, y formación educativa superior universitaria. Trabajan en laboratorios clínicos, hospitales, y centros de investigación y diagnóstico clínico.	Científico de laboratorio clínico, científico de anatomía patológica, titulado superior en análisis clínicos, microbiólogo, citólogo, histólogo, bacteriólogo, bioquímico

Código CNPS	Nombre	Código CIUO	Definición	Ejemplos de ocupaciones
11	Técnicos de laboratorio clínico y de anatomía patológica	3212	Los técnicos de laboratorio clínico y de anatomía patológica llevan a cabo exámenes y análisis clínicos en muestras de líquidos y tejidos corporales para obtener información sobre la salud de un paciente o la causa de una muerte. Prueban y manejan aparatos como espectrofotómetros, calorímetros y fotómetros de llama, para analizar materiales biológicos como la sangre, la orina y el líquido cefalorraquídeo.	Técnico de análisis clínicos, técnico de laboratorio clínico, técnico de banco de sangre, técnico de citología, técnico de anatomía patológica
12	Técnicos de diagnóstico por imagen y equipamiento terapéutico	3211	Los técnicos de diagnóstico por imagen y equipamiento terapéutico prueban y manejan los equipos de radiografía, ecografía y otras técnicas de diagnóstico que generan imágenes de las estructuras corporales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, traumatismos y otras deficiencias. Además, pueden administrar los tratamientos de radioterapia y controlar el estado de los pacientes bajo la supervisión de un radiólogo u otro profesional de la salud.	Técnico de radiología, técnico de diagnóstico por imagen, técnico de radioterapia, técnico de resonancia magnética nuclear, técnico de medicina nuclear, mamografista, ecografista
13	Profesionales de salud ambiental y ocupacional	2263	Los profesionales de salud ambiental y laboral evalúan, planifican y aplican los programas para reconocer, vigilar y controlar los factores ambientales que pueden afectar la salud humana, asegurar condiciones laborales seguras y saludables, y prevenir las enfermedades o lesiones causadas por agentes químicos, físicos, radiológicos y biológicos o por factores ergonómicos.	Responsable de salud ambiental, asesor de seguridad y salud en el trabajo, higienista laboral, asesor de radioprotección
14	Inspectores/asociados de salud ambiental y ocupacional	3257	Los inspectores/asociados de salud ambiental y ocupacional investigan la aplicación de las normas y reglamentos relativos a los factores ambientales que pueden afectar la salud humana, la salud y seguridad en el lugar de trabajo, y la seguridad de los procesos de producción de bienes y servicios. Pueden aplicar y evaluar los programas para restablecer o mejorar la seguridad y las condiciones higiénicas bajo la supervisión de un profesional de la salud.	Inspector de salud/sanidad, inspector sanitario de seguridad sanitaria, inspector de higiene y salubridad de los alimentos, inspector de seguridad y salud en el trabajo, inspector de seguridad y salud laboral/ocupacional, sanitarista, inspector sanitario
15	Profesionales de medicina tradicional y complementaria	2230	Los profesionales de medicina tradicional y complementaria exploran a los pacientes y previenen y tratan enfermedades, afecciones, traumatismos y otras dolencias físicas, mentales y psicosociales aplicando conocimientos, habilidades y prácticas adquiridas mediante el estudio exhaustivo de las teorías y experiencias originadas en culturas específicas. Investigan, desarrollan y aplican planes de tratamiento basados en técnicas como la acupuntura, la medicina ayurvédica, la homeopatía y la fitoterapia.	Acupunturista, médico ayurvédico, profesional ayurvédico, médico en fitoterapia china, homeópata, naturópata, practicante Unani (profesional de la medicina Unani [tradición médica árabe/persa]), Drungtsho (médico de la medicina tradicional tibetana)

Código CNPS	Nombre	Código CIUO	Definición	Ejemplos de ocupaciones
16	Asociados de medicina tradicional y complementaria	3230	Los asociados de medicina tradicional y complementaria previenen, atienden y tratan enfermedades, traumatismos, afecciones físicas y trastornos mentales mediante plantas medicinales y otros tratamientos basados en las teorías y experiencias originadas en culturas específicas. Administran los tratamientos empleando técnicas y medicamentos tradicionales, ya sea de manera independiente o conforme a los planes de tratamiento establecidos por un profesional titulado de medicina tradicional u otro profesional de la salud.	Técnico de acupuntura, técnico ayurvédico, técnico de homeopatía, osteópata, herborista, técnico de ventosas, sMenpas (profesional en medicina tradicional oriental)
17	Trabajadores comunitarios de la salud	3253	Los trabajadores comunitarios de la salud prestan servicios de educación para la salud, derivación y seguimiento, manejo de casos, cuidados básicos de prevención y salud, y visitas a domicilio para comunidades específicas. Proporcionan apoyo y ayuda a las personas y familias para orientarse y manejarse en el sistema de servicios sociales y de salud.	Trabajador comunitario de salud, auxiliar/ asistente comunitario de la salud, promotor comunitario de salud, trabajador de salud del pueblo, voluntario de salud de la comunidad, agente de salud
18	Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud	5321	Los trabajadores de los cuidados personales prestan servicios de cuidado personal directo en entornos hospitalarios, asistenciales y residenciales, ayudan en los procedimientos de atención de salud, y desempeñan muchas otras tareas de naturaleza sencilla y rutinaria para la prestación de servicios de salud. Estas ocupaciones requieren normalmente saber leer y escribir, nociones básicas de aritmética, un elevado nivel de destreza manual y buenas habilidades de comunicación interpersonal.	
18.1	Asistentes de cuidados de la salud	5321	Los asistentes de cuidados para la salud prestan cuidados personales rutinarios, brindan apoyo y ayuda con las actividades cotidianas de los pacientes y residentes en diversos entornos de atención de salud, como hospitales, clínicas, sanatorios y residencias. Ayudan a los pacientes en sus necesidades personales, de movilidad física y de cuidados terapéuticos conforme a las prácticas y los planes establecidos de cuidados, por lo general bajo la supervisión directa del personal médico, de enfermería u otros profesionales superiores de la salud o profesionales asociados.	Asistente de cuidados de enfermería (hospital o clínica), asistente de cuidados al paciente, asistente del nacimiento (hospital o clínica)

Código CNPS	Nombre	Código CIUO	Definición	Ejemplos de ocupaciones
18.2	Trabajadores de los cuidados personales a domicilio	5322	Los trabajadores de los cuidados personales a domicilio prestan cuidados personales rutinarios, brindan apoyo y ayuda con las actividades cotidianas de los pacientes y residentes en los hogares y en diversos entornos de atención de salud, como clínicas, sanatorios y residencias. Ayudan a los pacientes en sus necesidades personales, de movilidad física y de cuidados terapéuticos conforme a las prácticas y los planes establecidos de cuidados, por lo general bajo la supervisión directa del personal médico, de enfermería u otros profesionales superiores de la salud o profesionales asociados.	Asistente de enfermería (domicilio), asistente de enfermería domiciliario, asistente de cuidado en el hogar, asistente de puericultura, prestador de cuidados personales
18.3	Trabajadores de los cuidados personales en los servicios de salud, no especificados en otra parte	5329	Asistentes de cuidado personal que prestan cuidados personales rutinarios, brindan apoyo y ayuda con las actividades cotidianas de los pacientes y residentes en diversos entornos de atención de salud, como hospitales, clínicas, sanatorios y residencias. Ayudan a los pacientes en sus necesidades personales, de movilidad física y de cuidados terapéuticos conforme a las prácticas y los planes de cuidados establecidos, por lo general bajo la supervisión directa del personal médico, de enfermería u otros profesionales superiores de la salud o profesionales asociados.	Asistente dental, asistente de primeros auxilios, asistente hospitalario, ayudante de diagnóstico por imagen, asistente de farmacia, asistente de esterilización
19	Fisioterapeutas	2264	Los fisioterapeutas evalúan, planifican y aplican programas de rehabilitación destinados a mejorar o restablecer las funciones motoras humanas, aumentar al máximo la movilidad, aliviar los síndromes dolorosos, y tratar o prevenir los problemas físicos asociados a traumatismos, enfermedades y otras deficiencias. Aplican una amplia gama de técnicas y tratamientos físicos, como la movilización, los ultrasonidos, el calor, los rayos láser y otras técnicas. Pueden desarrollar y ejecutar programas para el tamizaje y la prevención de afecciones y trastornos físicos frecuentes.	Fisioterapeuta, fisioterapeuta geriátrico, fisioterapeuta ortopédico, fisioterapeuta traumatológico, fisioterapeuta pediátrico
20	Técnicos y asistentes de fisioterapia	3255	Los técnicos y asistentes de fisioterapia aplican tratamientos fisioterapéuticos a los pacientes en circunstancias en que la movilidad funcional esté amenazada por traumatismos, enfermedades o deficiencias. Adaptan los dispositivos de apoyo físico a los pacientes, y administran y supervisan los tratamientos manuales, eléctricos, ultrasónicos y otros tratamientos físicos. Dichos tratamientos suelen aplicarse de conformidad con los planes de rehabilitación establecidos por un fisioterapeuta u otro profesional de la salud.	Técnico de fisioterapia, técnico de rehabilitación física, terapeuta de acupresión, electroterapeuta, hidroterapeuta, masoterapeuta, masajista terapéutico, terapeuta shiatsu

Código CNPS	Nombre	Código CIUO	Definición	Ejemplos de ocupaciones
21	Dietistas	2265 (parte)	Los dietistas evalúan, planifican y aplican programas destinados a mejorar las repercusiones de la alimentación y la nutrición en la salud humana. Pueden desempeñar actividades de investigación, evaluación y docencia para mejorar el estado nutricional de personas individuales o comunidades.	Dietista, dietista clínico, dietista de servicio de alimentación
22	Nutricionistas	2265 (parte)	Los nutricionistas evalúan, planifican y aplican programas destinados a mejorar las repercusiones de la alimentación y la nutrición en la salud humana. Pueden desempeñar actividades de investigación, evaluación y docencia para mejorar el estado nutricional de personas individuales o comunidades.	Nutricionista, nutricionista de salud pública, nutricionista deportivo
23	Fonoaudiólogos y terapeutas del lenguaje	2266	Los fonoaudiólogos y terapeutas del lenguaje evalúan, manejan y tratan los trastornos físicos que afectan la audición, la comunicación hablada y la deglución en las personas. Prescriben dispositivos correctores o tratamientos rehabilitadores para la hipoacusia, los trastornos del habla y los problemas sensoriales y neurales relacionados. Planifican programas de tamizaje auditivo y proporcionan asesoramiento sobre seguridad auditiva y desempeño comunicativo.	Audiólogo, logopeda, foniatra, fonoaudiólogo, terapeuta del lenguaje
24	Optometristas	2267	Los optometristas prestan servicios de diagnóstico, manejo y tratamiento para los trastornos de los ojos y el sistema visual. Aconsejan y asesoran sobre cuidados y seguridad ocular, y prescriben anteojos, dispositivos ópticos u otros tratamientos para los trastornos de la vista.	Óptometra, optometrista, ortopedista óptico
25	Dispensadores ópticos	3254	Los dispensadores ópticos diseñan, adaptan y dispensan lentes ópticas a partir de la receta o prescripción de un oftalmólogo u optometrista para corregir situaciones de disminución de la agudeza visual. Llevan a cabo el mantenimiento de anteojos correctores, lentes de contacto, lupas y otros dispositivos ópticos.	Dispensador óptico, óptico de lentes de contacto
26	Técnicos de prótesis médicas	3214 (parte)	Los técnicos de prótesis médicas diseñan, ajustan, mantienen y reparan prótesis dentales y otros aparatos médicos y dentales siguiendo la prescripción o las instrucciones establecidas por un profesional superior de la salud. Pueden ocuparse del mantenimiento de una amplia gama de prótesis y dispositivos de apoyo para corregir problemas médicos y dentales de tipo físico, como collarines cervicales, férulas ortopédicas, miembros artificiales, audífonos, plantillas ortopédicas, dentaduras postizas, coronas dentales y pónicos.	Técnico en prótesis médicas, ortopedista, técnico en ortesis, protésico, técnico protésico

Código CNPS	Nombre	Código CIUO	Definición	Ejemplos de ocupaciones
27	Técnicos de registros sanitarios	3252	Los técnicos de registros sanitarios desarrollan, ejecutan y evalúan los sistemas de procesamiento, almacenamiento y recuperación de historias clínicas en hospitales y otros establecimientos médicos o de atención de salud con el fin de satisfacer los requisitos legales, profesionales, éticos y administrativos de mantenimiento de las historias clínicas en la prestación de servicios de salud.	Técnico de registros sanitarios, empleado de información sanitaria, analista de registros sanitarios, supervisor de la unidad de registros de salud, codificador clínico, técnico en registro de enfermedades
28	Asistentes médicos	3256	Los asistentes médicos desempeñan tareas administrativas y clínicas básicas de apoyo a la atención del paciente bajo la supervisión directa de un médico u otro profesional superior de la salud. Llevan a cabo tareas y procedimientos rutinarios como medición de los signos vitales de los pacientes, administración de medicamentos e inyecciones, registro de la información en los sistemas de mantenimiento de la historia clínica, preparación y manipulación de instrumental y suministros médicos, y recolección y preparación de las muestras de líquidos y tejidos corporales para su análisis.	Asistente médico, asistente clínico, asistente oftalmológico, asistente de salud
29	Trabajadores de ambulancia (técnicos de emergencia prehospitalaria)	3258	Los trabajadores de ambulancia brindan atención médica de emergencia a pacientes que están lesionados, enfermos o con algún otro impedimento físico o mental antes y durante el transporte a centros de salud, de rehabilitación y otros servicios. Vigilan los cambios en el estado de salud del paciente durante el transporte y efectúan diversos procedimientos según el protocolo de tratamiento médico de emergencia. Pueden patrullar y ofrecer información sobre primeros auxilios en actividades públicas multitudinarias y otros eventos en los que es probable que ocurran emergencias de salud.	Técnico en emergencias sanitarias, técnico de emergencias médicas prehospitalarias, paramédico de emergencia (no incluyen conductores de ambulancia)
30	Trabajadores sociales y orientadores profesionales	2635	Los trabajadores sociales y orientadores profesionales prestan servicios de orientación, acompañamiento, asesoramiento, terapia y mediación a personas, familias, grupos y comunidades en respuesta a dificultades sociales y personales. Ayudan a las personas a desarrollar habilidades y recursos de acceso, y respaldan los servicios necesarios para responder a las cuestiones suscitadas por problemas de salud, etapas de transición vital, adicciones y otros problemas personales, familiares y sociales. Actúan como agentes de enlace con otras entidades de servicios sociales, centros educativos y prestadores de servicios de salud para intentar remediar las necesidades de las personas y la comunidad.	Orientador en adicciones, orientador de duelo, trabajador social de servicio clínico, trabajador de bienestar social distrital, asesor de violencia de género, asesor de bienestar de la mujer

Código CNPS	Nombre	Código CIUO	Definición	Ejemplos de ocupaciones
31	Personal asociado de trabajo social	3412	El personal asociado de trabajo social administra y aplica los programas de asistencia social y los servicios comunitarios, y ayuda a las personas a afrontar sus problemas personales y sociales.	Trabajador de desarrollo comunitario, trabajador de servicios comunitarios, trabajador de servicios para personas con discapacidad, trabajador de servicios familiares, trabajador de servicios de apoyo de salud mental
32	Ingenieros biomédicos	2149	Este grupo incluye a quienes realizan investigaciones y asesoran o desarrollan procedimientos y soluciones de ingeniería biomédica.	Ingeniero biomédico
33	Psicólogos	2634	Los psicólogos estudian e investigan los procesos mentales y el comportamiento de los seres humanos como personas individuales o en grupo, y aplican dicho conocimiento para favorecer el ajuste y desarrollo personal, social, educativo o laboral.	Psicólogo clínico, psicólogo educativo/ pedagogo, psicoterapeuta
34	Administrativos médicos	3344	Los administrativos médicos disponen de conocimiento especializado de la terminología médica y de los procedimientos de prestación de servicios de salud, y ayudan a los otros profesionales y los trabajadores de la salud llevando a cabo diversas funciones de comunicación, documentación, labores administrativas y coordinación interna en establecimientos médicos y otros centros relacionados con la atención de salud.	Trabajador de desarrollo comunitario, trabajador de servicios comunitarios, trabajador de servicios para personas con discapacidad, trabajador de servicios familiares, trabajador de apoyo a la salud mental
35	Personal directivo	1342 (parte)	Los gerentes de servicios de salud planifican, dirigen, coordinan y evalúan la prestación de servicios clínicos y de salud comunitaria en hospitales, centros de salud, consultorios, organismos de salud pública y otras organizaciones afines. Proporcionan la orientación general, las normas de política y los criterios operativos para las unidades que dirigen, incluida la supervisión y evaluación de la contratación, capacitación y actividad laboral del personal. Vigilan el uso de los recursos y servicios de salud. Actúan de enlace con otros prestadores de servicios de salud y bienestar social, comisiones y entidades de financiamiento para coordinar la prestación de los servicios. El personal directivo abarca también a los gerentes y los administradores no clasificados en otra parte (excluidos los gerentes de servicios de salud) que trabajan en los sistemas de salud (por ejemplo: altos cargos de departamentos gubernamentales de salud, gerentes de recursos humanos, gerentes de la cadena de suministro, directores regionales de planificación y políticas de salud, y otros cargos cuyas principales tareas y responsabilidades incluyan la orientación y dirección de las actividades de organismos, instituciones, departamentos u otros trabajadores).	Director/administrador de establecimiento de salud, director/administrador médico, director clínico, directora de enfermería, matrona/partera jefa de hospital, coordinador de atención de salud comunitaria, director de salud pública. Jefe de departamento de salud del gobierno, gerente de recursos humanos, gerente de adquisiciones de productos médicos, director regional de planificación de la salud, gerente de servicios de atención a la tercera edad, gerente de bienestar social, gerente de servicios de información, comunicaciones y tecnología

Código CNPS	Nombre	Código CIUO	Definición	Ejemplos de ocupaciones
36	Personal administrativo	NA	El personal administrativo desempeña funciones de apoyo administrativo y organización en espacios de trabajo. Se encarga de tareas como atención al público, gestión de documentación, coordinación de agendas, comunicación interna y externa, manejo de correspondencia y archivo, contribuyendo así al funcionamiento de la organización.	Recepcionistas, secretarias
37	Personal de sistemas de información de salud	NA		Encargado/oficial de sistemas de información de salud, gestor de datos, administrador de bases de datos, desarrollador informático, ingeniero de redes, trabajadores de soporte informático
38	Personal de ingeniería y mantenimiento	NA		Ingeniero electricista, plomero, operador de maquinaria
39	Otros profesionales sin funciones médicas	NA		Contador, contable, economista, asesor fiscal
40	Otros trabajadores de apoyo sin funciones médicas	NA		Choferes, aseadores, porteros, empleado de seguridad

Nota: el cálculo para médicos, personal de enfermería y personal de partería se realiza con la sumatoria del personal incluido en los códigos CIUO que se encuentran en las subcategorías 1, 2 y 3 de cada código CNPS, las cuales son mutuamente excluyentes. Ejemplo: para los médicos, el código CNPS es 1, por lo que el cálculo representa la suma del total obtenido para el "Código CIUO" en la filas 1.1, 1.2 y 1.3 (2211+2212+221).

CIUO: Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones; CNPS: cuentas nacionales del personal de salud; NA: no aplica.

Fuente: elaboración propia, con base en Organización Mundial de la Salud. Classifying Health Workers: Mapping Occupations to the International Standard Classification. Ginebra: OMS; 2019. Disponible en: <https://www.who.int/publications/m/item/classifying-health-workers>; Organización Mundial de la Salud. Cuentas Nacionales del Personal de Salud: Un manual [National Health Workforce Accounts: A Handbook]. Ginebra: OMS; 2019. Disponible en: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/330361/9789243513119-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Anexo 2.

Lista de palabras para la búsqueda de ocupaciones

A continuación, se presenta la lista de palabras clave utilizadas para buscar los documentos con información de las ocupaciones en cada país. Las palabras marcadas con un asterisco corresponden a términos con uno o más caracteres comodín.

Palabras clave en inglés

Acupuncturist; Aged Care; Ambulance; Anesthetist; Biochemical; Biologist; Biologists; Biology; *Biomedic; Biomedicine; Blood; Blood Extractionist; Blood Pressure Controller; Bodily; Body; Botanists; Bromatologist; Bromatology; Care; Caregiver; Chemical Analysis; Child Stimulating; Chiropracist; Chiropractors; Clinic; Clinical Analysis Laboratory; Community Health; Contactologist; Dental; Dental Assistant; Dental Mechanic; Dental Prosthetists; Dentist; Diet; Diet and Nutrition; Dieticians; Digitopunturist; Doctor; Drugstore; *Electromedicin; Energetic; Energy Therapist; Environmental; Environmental Health; Eutonist; First Aid Lifeguard; Food Hygiene; Health; Hemotherapy; Histopathologist Technician; Histotechnical; Hospitable; Hospital; Hygiene; Kinesiologist; Laboratory; Masotherapist; Matron; Medical; Medicinal; Medicine; Mental Health; Midwife; Midwifery; Neonatology; Neurologist; Nurse; Nursing; Nutrition; Nutritionists; Obstetric; Occupational Therapist; Odontology; Operating; Operating Room; Ophthalmic; Ophthalmologist; Optical; Opticians; Optics; Optometrist; Optometrists; Optometry; Orthodontist; Orthopedist; Orthosis; Pedicure; Pedicuro; Personal Trainer; Pharmaceutical; Pharmacist; Pharmacy; Phoniatrician; Phonoaudiologist; Physical; Physical Conditioning; Physical Education; Physiotherapist; Physiotherapy; Podiatrist; Practitioner; Psychiatrist; Psychographologist; Psychologist; Psychomotrist; Psychotherapist; Puericultor; Radiologist; Sanatorium; Sanitarist; Sanitary; Seniors; Social Service; Social Welfare; Speech Therapist; Speech Therapy; Sterilization; Suicide; Suicide Prevention; Surgery; Surgical; Therapeutic; Therapeutic Companion; Therapist; Therapist Musician; Traumatologist; Vaccination; *Vet; Veterinary; Zoologist; Zoonosis

Palabras clave en español

Acondicionamiento físico; Acupunturista; Ambiental; Ambulancia; Análisis químico; Anestesista; Ayudante de dentista; Bienestar social; Biología; Biólogo; Biólogos; Biomedicina; Biomédico; Bioquímico; Botánicos; Bromatología; Bromatólogo; Cirugía; Clínica; Compañero terapéutico; Contactólogo; Controlador de presión arterial; Corporal; Cuerpo; Cuidado; Cuidado de ancianos; Cuidador; Dental; Dentista; Dieta; Dieta y nutrición; Dietistas; Digitopunturista; Doctor; Educación física; Electromedicina; Energético; Enfermería; Enfermero; Entrenador personal; Esterilización; Estimulador del niño; Eutonista; Extraccionista de sangre; Facultativo; Farmacéutico; Farmacia; Físico; Fisioterapia; Fisioterapeuta; Foniatra; Fonoaudiólogo; Hemoterapia; Higiene; Higiene alimenticia; Hospital; Hospitalario; Kinesiólogo; Laboratorio; Laboratorio clínico; Logopeda; Masterapeuta; Matrona; Matronería; Mecánico dental; *Médico; Medicamento; Medicina; Neonatología; Neurólogo; Nutrición; Nutricionistas; Obstétrico; Odontología; Odontólogo; Oftálmico; Oftalmólogo; Operando; *Óptica; Optometría; Optometrista; Optometristas; Órtesis; Ortodoncista; Ortopedista; *Oftalmología; Partera; Partería; Pedicure; Pedicuro; Podólogo; Prevención del suicidio; Protesista dental; Psicografía; Psicólogo; Psicomotrista; Psicoterapeuta; Psiquiatra; Puericultor; *Quiropráctico; Quirúrgico; Radiólogo; Sala de operaciones; Salud; Salud ambiental; Salud de la comunidad; Salud mental; Salvavidas de primeros auxilios; Sanatorio; Sangre; Sanitario; Sanitarista; Seniors; Servicio social; Suicidio; Técnico histopatólogo; Terapeuta; Terapeuta de energía; Terapeuta musical; Terapeuta ocupacional; Terapéutico; Terapia del lenguaje; Traumatólogo; Vacunación; Veterinario; Zoólogo; Zoonosis

Palabras clave en português

Acupunturista; Ambiental; Ambulância; Análises químicas; Anestesista; Assistente de dentista; Bem-estar social; Biologia; Biólogo; Biólogos; Biomedicina; Biomédico; Bioquímica; Botânicos; Bromatologia; Bromatologista; Cinesiologista; Cirurgia; Cirúrgico; Clínica; Comida higiênica; Companheiro terapêutico; Condicionamento físico; Contactologista; Controlador de pressão arterial; Corpo; Corporal; Criança estimulante; Cuidado; Cuidador; Cuidados a idosos Dental; Dentista; Dieta; Dieta nutrição; Digitopunturista; Doutor; Drogaria; Educação física; Electromedicina; Enérgico; Enfermagem; Enfermeira; Esterilização; Eutonista; Extracionista de sangue; Farmacêutico; Farmácia; Físico; Fisioterapeuta; Fisioterapia; Foniatra; Fonoaudiologista; Hemoterapia; Higiene; Histotécnico; Hospital; Hospitaleiro; Idosos; Laboratório; Laboratório de análises clínicas; Masoterapeuta; Matrona; Mecânico dental; *Médico; Medicamento; Medicina; Neonatologia; Neurologista; Nutrição; Nutricionistas; Obstetrícia; Obstétrico; Odontologia; Oftálmico; Oftalmologista; Operativo; *Ópticas; Óptica; Óptico; Optometria; Optometrista; Optometristas; Órtese; Ortodontista; Ortopedista; Parteira; Pedicure; Pedicuro; Podiatra; Praticante; Prevenção de suicídio; Primeiros socorros salva-vidas; Protestista dental; Psicografologista; Psicólogo; Psicoterapeuta; Psiquiatra; Psicomotricista; Puericultor; *Quiroprático; Radiologista; Sala de operação; Sanatório; Sangue; Sanitário; *Sanitarist; Saúde; Saúde ambiental; Saúde da comunidade; Saúde mental; Serviço social; Suicídio; Técnico em histopatologia; Terapeuta; Terapeuta da fala; Terapeuta de energia; Terapeuta músico; Terapeuta ocupacional; Terapêutico; Terapia de fala; Traumatologista; Treinador pessoal; Vacinação; Veterinário; Zoólogo; Zoonose

Anexo 3.

Herramienta de mapeo de ocupaciones, información recopilada

- Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), código
- CIUO correspondiente
- Clasificación nacional, código
- Clasificación nacional correspondiente
- Definición (escriba una breve descripción de la ocupación)
- ¿Esta ocupación está regulada? (Sí/No/No aplica)
- Indique la norma que la regula
- Actividades (escriba una breve descripción de las actividades que pueden ser desempeñadas por esta ocupación)
- Indique en qué nivel de atención puede ser incluida esta ocupación (coloque las opciones que sean necesarias).
Ejemplo: centros de atención primaria, hospitales con y sin internación, minoristas
- ¿Esta ocupación está incluida en los equipos de atención primaria de salud? (Sí/No)
- Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE):
 - Nivel CINE 0 – Educación de la primera infancia
 - Nivel CINE 1 – Educación primaria
 - Nivel CINE 2 – Educación secundaria baja
 - Nivel CINE 3 – Educación secundaria alta
 - Nivel CINE 4 – Educación postsecundaria no terciaria
 - Nivel CINE 5 – Educación terciaria de ciclo corto
 - Nivel CINE 6 – Educación terciaria o nivel equivalente
 - Nivel CINE 7 – Maestría, especialización o equivalente
 - Nivel CINE 8 – Doctorado o equivalente
- ¿Esta carrera se encuentra regulada? (Sí/No)
- Si respondió “Sí”, indique la norma
- ¿Esta carrera tiene acreditación obligatoria? (Sí/No/No aplica)
- Cite las normas que establecen la acreditación de las carreras
- Enumere las denominaciones de las titulaciones correspondientes a esta ocupación
- Coloque los requisitos educativos para el ingreso a la formación de esta carrera
- Indique la cantidad mínima de horas o años requeridos para la carrera
- Indique cantidad de instituciones formadoras públicas (cite año)
- Indique cantidad de instituciones de formación privadas (cite año)
- Indique cantidad de egresados anuales (cite año)
- Notas (agregue información sobre normativas, leyes y otra que considere necesaria)

Mapeo de ocupaciones de salud. Una metodología para su aplicación en la Región de las Américas constituye una herramienta para la identificación y descripción de las ocupaciones del sector, elaborada como un recurso esencial por el Equipo de Evidencia e Información de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud.

Esta publicación contiene una de las tres metodologías diseñadas en colaboración técnica con los países de la Región de las Américas en el marco de la iniciativa de fortalecimiento de los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS). Las dos metodologías que complementan la presente son el mapeo de actores y diálogo estratégico del ámbito de los recursos humanos para la salud (RHS) y la evaluación de la madurez de los SIRHS.

En este documento se describe la metodología propuesta para el reconocimiento de los grupos ocupacionales de salud en cada país, alineados con las categorías y codificaciones del Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones y con los clasificadores de los propios países. Para cada ocupación se indagan su definición, las actividades que comprende, los ámbitos de desempeño, la regulación del ejercicio profesional, la formación y las titulaciones.

La herramienta ofrece directrices prácticas para su aplicación y fue diseñada con el fin de establecer estándares comunes que permitan interrelacionar distintas bases de datos de RHS en un mismo país y favorecer la comparabilidad internacional. Con su implementación, se busca apoyar a los responsables de las políticas públicas en la comprensión y el fortalecimiento de sus capacidades en materia de RHS, de modo que puedan promover el desarrollo de sistemas de información más sólidos y eficaces que faciliten la toma de decisiones informadas.



www.paho.org



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
Región de las Américas